

PLEURÉSIE HÉMORRAGIQUE

Dr A. Alioua

Maitre assistante en pneumophtisiologie

Centre hospitalo-universitaire de Constantine

Plan

- I. Définition
- II. Diagnostic
- III. Diagnostic différentiel
- IV. Diagnostic étiologique
- V. Traitement

I. Définition

- ❑ La pleurésie hémorragique est la présence d'un liquide pleural de couleur rosée, sérohématique ou franchement sanglant incoagulable .
- ❑ Représente 9- 15% de toute les pleurésies .

II. Clinique

❑ Pas de particularité

1- Signes généraux : dépendent de l'étiologie

2- Signes fonctionnels : Développement insidieux

- douleur élément fréquent ++
- Dyspnée progressive en rapport avec l'abondance
- Toux sèche de type pleural

3- Signes physiques : syndrome pleural liquidien

(Triade de trousseau)

- Vibrations vocales diminuées à la palpation ou abolie .
 - Matité à la percussion .
 - Murmure vésiculaire diminué à l'auscultation ou abolie .
- Syndrome anémique plus ou moins important .

III Paraclinique

1- Radio du thorax :

- Objective l'épanchement pleural liquidien: l'opacité est déclive, comble le cul-de-sac pleural , à limite supérieure courbe concave à concavité interne et à sommet axillaire.
- Chercher les lésions pulmonaires associées

Radio du thorax

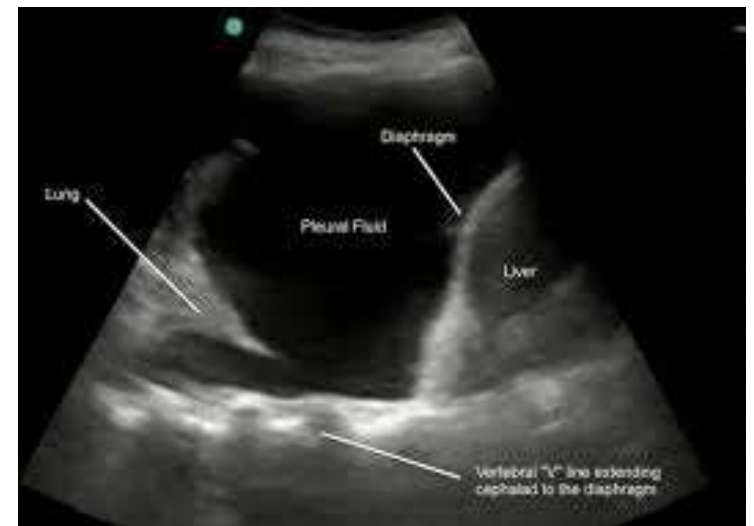


III Paraclinique

2- Echographie ou scanner thoracique

- Grand intérêt diagnostique
- Permet de mesure millimétrique de la plèvre
- Rechercher une masse tumorale associée
- Guider la ponction et /ou la biopsie pleurale

Echographie transthoracique



3 -Ponction pleurale:

- Aspect macroscopique : dépend de la concentration des érythrocytes
 - Si nombre des érythrocyte est entre[5000-6000 GR/mm³] =Rosé
 - Si nombre des érythrocyte est > 10000 GR/mm³ = Séro-hématique
 - Si nombre des érythrocyte est > 100000 GR/mm³ =Franchement sanglant
- Etude biochimique : liquide exsudatif , riche en protéine
- Etude cytologique:
 - Les éosinophiles sont souvent abondants dans le liquide pleural des pleurésies hémorragiques, de même que les cellules mésotheliales.
 - Rechercher les cellules malignes ++
- Etude bactériologique : recherche des germes avec culture

Ponction pleurale



4- Biopsie pleurale:

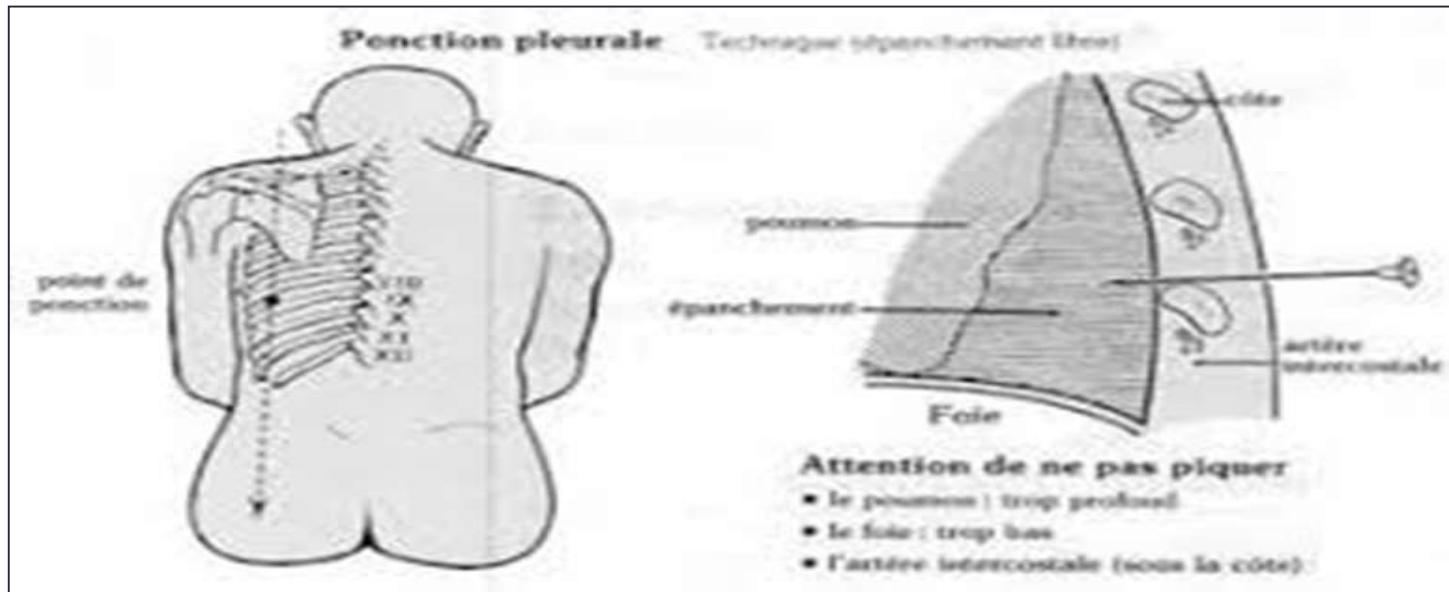
- Absence de contre indications: un bilan d'hémostase perturbé, malade grabataire
- Réalisée à l'aveugle et/ou sous contrôle échographique

Biopsie pleurale



IV. Diagnostic différentiel

- ❑ Une Pique mal systématisé d'un vaisseau intercostal
- ❑ Pleurésie à liquide clair transformée en hémorragique suite à des ponctions répétées traumatisantes



IV. Diagnostic différentiel

- ❑ Hémothorax : dont l'hématocrite du liquide est supérieur ou égal à 50% de l'hématocrite du sang
 - Hémothorax post-traumatique suite à un traumatisme pénétrant ou contondant Ou iatrogène : ponction directe de l'aorte dorso-lombaire
 - Hémothorax spontané : trouble de la coagulation (Hémophilie)
 - Hémopneumothorax: entité particulière (rupture d'une bride)

V. Diagnostic étiologiques

1- Etiologies malignes

- Pleurésies hémorragiques secondaires : cancer pulmonaire ,cancer extra-pulmonaire (sein ,rein, orl, hémopathies malignes....)
- Pleurésie hémorragique primitive (le mésothéliome):
 - Douleur intense avec pleurésie récidivante
 - Aspect mamelonné de la plèvre
 - Diagnostic positif :biopsie pleurale par thoracoscopie

2- La tuberculose:

- Les pleurésies hémorragiques d'origine tuberculeuse sont exceptionnelles .
- Le diagnostic : la biopsie pleurale à l'aiguille.
- L'évolution est plus lente que les pleurésies sérofibrineuses tuberculeuses

3- Embolie pulmonaire avec infarctus cortico-pleural:

- Le liquide est très inflammatoire avec une intense réaction mésothéliale ou macrophagique.
- Le diagnostic est confirmé par un angioscanner thoracique

4- Pancréatite:

- Pleurésie hémorragique gauche
- Aspect macroscopique noirâtre
- Evolution chronique
- Le taux d'amylopleurie est élevé.

5- Pleurésies infectieuses hémorragiques: germe responsable : Le Klebsella (BGN)

6- Pleurésie post-IDM et chirurgie cardiaque :

- Délai d'apparition de trois à six semaines.
- Souvent associée à une péricardite (polysérite).
- Liquide sérohémostatique.

VI. Traitement

❑ Le traitement est étiologique :

- Chimio-radiothérapie : En cas de pathologie tumorale .
 - une Symphyse pleurale chimique peut être indiqué devant les pleurésies néoplasiques récidivantes.
- Les antibiotiques pour les infections .
- Les anticoagulants en cas d'embolie pulmonaire .
- Traitement médical +/- chirurgical pour les pancréatites.

MERCI DE VOTRE ATTENTION